O.P. GRUGLIASCO - Comunità VILLA AZZURRA

L'inizio della comunità risale al luglio 1977 ed è il risultato di un programma di riabilitazione all'interno del reparto B44 maschile dello stesso ospedale.

Il progetto di lavoro ~~aveva~~ portato avanti dagli operatori aveva coinvolto tutto il gruppo di pazienti che erano stati individuati in base a criteri di competenza territoriale nei reparti dell'O.P. di Collegno ed in seguito trasferiti a Grugliasco.

Partendo da una realtà fortemente manicomiale si era giunti ad una situazione in cui i pazienti del reparto erano stati divisi in due gruppi: ~~i de~~ una di degenti particolarmente autosufficienti, l'altra di degenti ancora molto bisognosi di assistenza. La scelta fu quella di sancire per il primo gruppo di persone, il riconoscimento, attraverso le dimissioni, di quel libello di autonomia e di capacità di autodeterminazione maturate fino a quel momento. L'esperienza comunitaria doveva inoltre tendere verso una effettiva dimissione all'esterno e garantire comunque tutti quei rapporti con il mondo esterno che erano stati sviluppati nella precedente vita di reparto. Il distacco degli infermieri dal reparto, la loro disponibilità e completa adesione al progetto hanno fatto sì che si venisse a creare un clima di continuità di lavoro ~~degli operatori~~ e del rapporto interpersonale degli operatori con i pazienti.

Principio fondamentale del programma fu quello di non sancire con regole precise uno stile particolare di vita all'interno della comunità nel tentativo di mantenere quel clima di transitorietà che non garantisse e non significasse per alcuno una sistemazione definitiva ed immutabile.

~~All'inizio, nonostante l'alto numero di ospiti, e i grandi spazi dell'ex-reparto accettazione Villa Azzurra~~

All'inizio, dato l'alto numero degli ospiti, si privilegiò la coesione del gruppo e l'effettiva autonomia delle persone che ne facevano parte, cercando di portare a termine il processo di riabilitazione. La preoccupazione per gli eventuali disagi abitativi dovuti alla utilizzazione dei grandi spazi dell'interno complesso, venne messa in secondo piano e l'attenzione venne concentrata nel reperimento di strutture esterne in grado di accogliere piccoli gruppi di ospiti. Solo in un secondo tempo, quindi, con la riduzione numerica del gruppo iniziale, si affrontò il progetto di situazioni più specifiche tra cui la ristrutturazione dei locali che a questo momento consente agli ospiti di vivere in piccole comunità di una decina di persone in ambienti più raccolti e personalizzati. Tutto questo non inteso comunque ~~non~~ come situazione definitiva ma rientra nel progetto di passaggio all'esterno che per taluni ospiti potrà richiedere tempi più lunghi.

Il numero degli infermieri si è progressivamente ridotto in quanto alcuni sono rientrati alle équipes di zona per occuparsi delle comunità esterne. Gli operatori rimasti hanno via via modificato l'orario di lavoro concentrando la loro presenza nel corso della giornata. Un medico segue l'intero progetto, coordinando il lavoro degli infermieri ed intervenendo nell'effettiva attività di risocializzazione.

Come programma in corso di attuazione si prevede l'apertura di un servizio di mensa o meglio di un ristorante aperto al pubblico e, in modo particolare, a tutti gli ospiti delle comunità.

LE ORTENSIE.

STORIA DELLA COMUNITA'

* La dimissione è presentò particolarmente problematica perché oltre alla perdita di una collocazione residenziale avrebbe rappresentato anche la perdita di un'occupazione retribuita.

Il lavoro ~~è~~ iniziò almeno due anni prima che la comunità nascesse, e fu incentrato ~~dapprima~~ inizialmente su un gruppo di persone ~~molto~~ particolarmente attive che ~~erano~~ avevano ~~attivissime~~ lavorato nel bar del reparto D; ~~c'era~~ vi fu ~~il problema delle loro dimissioni, che non si poteva affrontare perchè, a causa della loro situazione lavorativa, se dimesse avrebbero perso il posto, cosa che le terrorizzava.~~

Si impose ~~allora~~ la ricerca di una ~~loro~~ sistemazione all'interno dell'ospedale stesso, mentre contemporaneamente si cercò ~~va~~ di ~~neutralizzare~~ coinvolgere l'intero reparto D ~~(cosa estremamente complessa, dato che si trattava di una sezione stagnante con personale arrivato alla fine della carriera e degenti cronici)~~ dal nulla, ~~lì depositato dopo molte vicende attraverso i vari reparti dell'ospedale~~.

~~Si era cominciò~~ Venne affrontato ~~col sistemare~~ la situazione pensionistica e ~~comunque col~~ a lato curare ~~gli~~ degli interessi economici dei pazienti, ~~col favorire i soggiorni estivi, le gite, eca~~; si giunse poi a formulare un programma di dimissioni (individualmente all'esterno e in comunità, con previsione di spostamento all'esterno) verificando così ~~nuovamente~~ la possibilità di ~~ridurre il~~ una riduzione del reparto del 50%. ~~La maggior~~ Parte del personale ~~era assolutamente~~ si dimostrò contrario alla formazione di comunità ~~perchè~~ in quanto si sarebbero sottratte ~~loro~~ le persone più valide, che lavoravano ~~proficuamente~~ in reparto. ~~Si~~ si proseguì, nel tentativo di reperire locali all'interno dell'ospedale (in un primo tempo, e senza successo, la casa colonica, poi gli appartamenti delle suore che invece furono concessi all'A 1).

Il programma di dimissioni del reparto D venne ~~comunque~~ bocciato, in quanto non era stato adeguatamente ~~motivando questo con il fatto che~~ il settore ~~psi~~ di provenienza dei pazienti, ~~ed il personale non erano sonizzati~~. ~~e che non si riusciva a trovare la giusta collo-~~

~~cazione al primario~~. ~~Alla fine~~ Si ripiegò, infine, su dei locali interni che si erano ~~per caso~~ liberati (ex-spogliatoio del personale dei bambini), ~~anche se a prima vista sembravano addirittura inagibili~~. ~~Peccato più tardi. In un secondo tempo, vennero tolti alla comunità due stanzoni, per cui ci si dovette limitare a far uscire dal reparto 17 persone~~. [Per mesi il rapporto di dipendenza dal reparto è rimasto fortissimo; ~~ci sarà un confronto continuo~~, anche perchè per le comunità nascenti non era stato programmato niente di preciso, [ ] ~~ed un vantaggio concreto, immediato, per chi si spostava, non era visibile~~.

~~Ad ogni modo~~, La comunità, nata il 3 luglio del 1978, è decollata faticosamente, riuscendo a trovare un ambulatorio disposto a farsene carico e ad ottenere dal reparto un turno di infermiere. (~~avrebbero dovuto essere 6, in realtà sono 4, 2 destinate allo ambulatorio e 2 alla comunità~~).

Al momento si cerca di ricostruire un rapporto con le famiglie, ponendosi inoltre il problema dell'inserimento in zona.